

УДК 616.43-039.42-07-08]-035.7

ББК 54.15

Р 33

Р 33 Редкие эндокринные заболевания и синдромы: трудности диагностики, ошибки: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. проф. *И.В.Терещенко*; Перм. гос. мед. академия. Пермь, 1999. 131 с.
ISBN 5-7812-0071-1

Представлены описания этиологии и патогенеза, клинических проявлений, диагностических признаков и особенностей лечения редких эндокринопатий. Приведены примеры из врачебной практики, дан анализ трудностей и ошибок в постановке диагноза и лечении.

Рецензенты:

д-р мед. наук, проф., член-кор. АН РТ,
засл. деятель науки РТ **В.В.Талантов**
(Казанский государственный медицинский университет);

д-р мед. наук, проф. **В.В.Трусов**
(Ижевская государственная медицинская академия)

ISBN 5-7812-0071-1

© Пермская государственная
медицинская академия, 1999

О БОЛЕЗНИ ДЕРКУМА

В.М.Атаманов, В.А.Голышева, Н.В.Светлакова

Пермская государственная медицинская академия

Болезнь Деркума (болезненный липоматоз, болезненное ожирение, адипозальгия) – редко встречающееся хроническое, протекающее с ремиссиями и обострениями заболевание, наиболее патогномоничным признаком которого является образование на различных участках тела болезненных липом. Впервые эта патология была описана в 1892 г. американским невропатологом F.X.Dercum'a под названием *adiposis dolorosa*. Болеют преимущественно женщины в возрасте 40-50 лет [5, 6, 8, 12], реже данная патология выявляется у мужчин, а также у детей [5, 7].

До настоящего времени этиология и патогенез болезни Деркума окончательно не выяснены. Большинство авторов признается роль гипоталамо-гипофизарного комплекса в развитии данной патологии, что послужило основанием для создания гипоталамической теории заболевания [2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13]. Такие проявления болезни, как нейроэндокринные, вегетативно-сосудистые, психические нарушения позволяют думать о поражении ядер переднего и заднего отделов гипоталамуса, одновременно холин- и адренергического субстрата сетчатой формации ствола головного мозга.

Электроэнцефалографические изменения аналогичны тем, которые обнаруживаются при состояниях, прямо или опосредованно связанных с функцией диэнцефальной области [13]. Болезнь Деркума рассматривается как приобретенная патология [1, 9] в тех случаях, когда заболевание развивается на почве поражения диэнцефальной области различными острыми и хроническими общесоматическими инфекциями, нейроинфекциями, токсическими, аллергическими факторами [5, 6, 7, 9], а также после черепно-мозговой травмы [3, 4], при алиментарной дистрофии, опухоли мозга [4]. Описаны также семейные формы болезненного липоматоза, что может быть связано с наличием наследственного дефекта ферментных систем, участвующих в липидном обмене. Он наследуется по аутосомно-доминантному типу со слабой проявляемостью [1, 9]. Присутствие дизрафических черт (врожденные дефекты развития костной системы и кишечника [12], аномалии почек [2]) при болезни Деркума является еще одним свидетельством в пользу наследственно-конституциональной природы заболевания [12]. По некоторым данным, семейная предрасположенность имеет место в 10% случаев [8]. А.А.Шутов считает необходимым различать болезнь Деркума как нозологическую форму и синдром Деркума, развивающийся вследствие органических заболеваний головного мозга с повреждением гипофизарно-гипоталамической области [10, 11]. Выделяют несколько форм болезни Деркума: узловую, диффузно-ограниченную, диффузно-генерализованную, а также смешанные. Узловая форма характеризуется появлением множественных подкожных узлов величиной от 0,5 до 6-8 см, локализация их разнообразная, несимметричная. При диффузно-ограниченной форме заболевания наблюдается образование крупных отложений жира на грудной стенке, животе, спине, бедрах. Диффузно-генерализованная форма характеризуется общим ожирением, более выраженным в нижних частях тела [7]. Жировые отложения в большинстве слу-

чаев имеют дольчатую структуру, плотную консистенцию, чрезвычайно болезненны при пальпации и мышечном сокращении. Кожа над ними обычно не изменена, спаяна с ними, иногда отмечается ее мраморность и синюшность [2, 4, 10, 11]. Морфологическим субстратом образования является жировая ткань с выраженной сетью кровеносных сосудов, что придает ему вид ангиолипомы; в просвете сосудов видны множественные тромбы, периваскулярно отмечаются некробиотические и некротические изменения с умеренно выраженной воспалительной кистозной инфильтрацией и склерозом [2]. Вследствие тромбоза и спазма артериол в ангиолипомах повышается чувствительность периферических симпатических окончаний к ишемии, что ведет к появлению болевых ощущений [7]. Липомы развиваются медленно, а первоначальными признаками заболевания могут быть астения, мышечная слабость, нарушение сна, снижение памяти, головная боль, головокружение, болевые ощущения в различных частях тела, психические нарушения, которые могут усугубляться — возникают депрессия, ипохондрия, нарколепсия, эпилептические припадки [4, 7, 10, 11]. У некоторых больных могут развиваться эндокринно-обменные расстройства в виде несахарного диабета, акромегалии, диспитуитаризма или адипозогенитальной дистрофии, трофические изменения кожи и ее придатков, артриты, экзостозы, сердечно-сосудистые нарушения [4, 10, 11]. В.Я.Эмануэль отмечает частое сочетание болезни Деркума с дисграфическим статусом [12, 13]. Жировые отложения обычно располагаются на туловище, плечах, бедрах, реже на предплечьях, лице [8]. Болевой феномен не всегда бывает выраженным и постоянным. По мнению некоторых исследователей, он даже не является патогномоничным [12]. В связи с вариабельностью клинических проявлений, редкостью данной патологии диагностика болезни Деркума бывает затруднена и ее принимают за другое заболевание — панникулит, хронический миозит, нейрофиброматоз, узловатую эритему и др. Однозначного подхода к лечению болезненного липоматоза не существует. В литературе высказываются противоречивые мнения о тактике ведения больных. Одни авторы считают необходимым оперативное лечение — иссечение жировых образований [4, 5, 8], утверждая, что радикально выполненные операции при ограниченных формах не только избавляют больных от косметических дефектов и болевых ощущений, но и нормализуют их психику [6]. По мнению других авторов, удаление жировых образований не излечивает болезнь Деркума, а больные нуждаются в лечении в условиях неврологиче-

ского стационара [3]. При диффузных формах болезненного липоматоза хороший эффект дает комплекс консервативных мероприятий: гормонотерапия, рентгенотерапия на лиэнцефальную область, седативные и нейроплегические препараты, витамины группы В, лечебная гимнастика, массаж, парафиновые аппликации на крупные узлы [6, 7]. Р.Аткинсон [14] указывает на эффективность при лечении этого заболевания внутривенного введения лидокаина.

Наблюдаемый нами больной Ш-н 45 лет отмечает, что первые опухолевидные болезненные образования появились у него в подкожно-жировой клетчатке предплечий в 25 лет (1979 г.). В течение первых 17 лет болезни примерно 1 раз в месяц возникала новая липома на руках или туловище. Размеры липом варьировались от 2-3 до 80-100 мм. При пальпации липом возникали болевые ощущения, особенно на этапе активного роста, иногда появлялось ощущение стягивания мышц. Эти явления уменьшались при стабилизации размера подкожного образования. Обратного развития образовавшейся опухоли больной не замечал. Последние 3 года (1997-1999 гг.) отмечает бурное образование липом на различных участках тела, но преимущественно на нижних конечностях. Не зафиксировано образования болезненных опухолей лишь на лице и шее. В период активного прогрессирования заболевания появляется примерно одна липома в неделю, часто это сопровождается тоническими судорогами в ногах в ночное время. Больного беспокоит повышенная раздражительность, вспыльчивость, головные боли диффузного характера. Неоднократно обращался к эндокринологам: предполагался нейрофиброматоз, распространенный липоматоз, но лечения предложено не было. Однократно лечился в отделении неврозов (1997 г.) после стрессового состояния на работе (был директором базы стройматериалов): появилась быстрая утомляемость, слабость, нарушился сон, стал «срываться» по мелочам на работе и дома. Психиатром отмечена фиксация на жалобах невротического характера, больной ориентирован, контактен, память на прошлые события грубо не страдает, в мышлении элементы обстоятельности. Считает себя человеком основательным, трудолюбивым, пунктуальным, обязательным, но прямым, не терпящим несправедливости, стремящимся всегда доказать свою правоту. Последнее обстоятельство ведет к усложнению отношений с родственниками и коллегами. Уровень притязаний, самооценки несколько завышен. Психический статус оценен как легкие изменения личности по органическому типу. В амбулаторных условиях, по совету знакомых, лечится настоями из трав, чаем из чаги, употребляет в пищу топинамбур.

Из анамнеза жизни известно, что родился и до 18 лет жил на севере Пермской области, в семье староверов, имеет 4 здоровых братьев и сестру. С детства страдает хроническим гнойным двусторонним мезотимпанитом, часто болела голова, и мать лечила его у знахарки. Сам больной связывает имеющийся у него липоматоз с тем, что в 1972 г. недалеко от поселка, где он жил, проводились ядерные взрывы с целью соединения каналом притоков Камы и Печоры. В последние 2 года появились выраженные явления парадентоза, перенес острый цистит, частые респираторные заболевания. Женат, имеет взрослую дочь.

Объективные данные: больной правильного телосложения, удовлетворительного питания, общего ожирения нет. На конечностях и туловище при визуальном осмотре и пальпации определяется множество плотных болезненных образований в подкожно-жировой клетчатке. Кожа над жировиком внешне не изменена, но с трудом собирается в складку. Патологии внутренних органов при осмотре не обнаружено. Пульс — 56 ударов в минуту. Артериальное давление 120/80 мм рт.ст. Общие анализы мочи и крови не изменены. При биохимическом исследовании крови выявлено повышение уровня серомукоида (0,34), СРП(+) (вероятно, проявление хронического мезотимпанита), снижение уровня фракции гамма-глобулина (10,7%) при нормальном общем белке (65,7 г/л) и других фракций: альфа (11,4%), бета (12,1%) и альбуминов (65,7%). Лабораторные показатели жирового обмена в норме. Электрокардиографические исследования свидетельствуют о тенденции к брадикардии. Неоднократно проводилась краниография, выявлено уплотнение твердой мозговой оболочки в теменной области, полное отсутствие ячеистости сосцевидных отростков, расширение венозных выпускников, турецкое седло небольших размеров (8-9 мм), замкнутое. Заключение: гиперостоз внутренней пластинки костей черепа, внутричерепная гипертензия. Рентгенография поясничного отдела позвоночника показала левосторонний сколиоз и сакрализацию пятого поясничного позвонка. С помощью крупнокадровой флюорографии грудной клетки выявлена плевродиафрагмальная спайка, обызвествленная плевра, частичная релаксация правого купола диафрагмы. При осмотре глазного дна выявлены бледно-розовые диски, артерии неравномерно расширены, вены умеренно расширены. Электроэнцефалография показала признаки легкой резидуальной недостаточности срединных структур головного мозга, эхоэнцефалография — дополнительные сигналы в незначительном количестве.

В представленной клинической ситуации отмечено большинство признаков диффузно-ограниченной формы болезни Дер-

кума. Имеются многочисленные болезненные, спаянные с кожей опухолевидные образования в подкожной клетчатке, при отсутствии общего ожирения, выраженный астеноневротический синдром. Выявленные в нашем случае клинико-рентгенологические признаки внутричерепной гипертензии, гиперостоза, «малого», «закрытого» турецкого седла не описаны другими авторами при болезни Деркума, их роль в происхождении болезненного липоматоза пока не ясна. Диагностика заболевания обычно не сложна, но лечение не разработано. Вероятно, показаны анальгезирующие препараты, в том числе и лидокаин. Хирургическое лечение рекомендуется лишь при значительном сдавливании сосудисто-нервных пучков либо для ликвидации косметического недостатка.

Список литературы

1. Гаджиев Х.Э., Шамов И.А., Магомедов Ш.М. // Клини. мед. 1970. Т. 48. №7. С.133.
2. Глотов Н.Ф., Васин В.А., Кирюхина Г.А. // Сов. мед. 1989. №2. С.111.
3. Грейда Б.П., Мудрик В.А. // Сов. мед. 1973. № 12. С.122.
4. Грейда Б.П., Ткаченко Т.А. // Вестн. хирургии им. И.И.Грекова. 1983. №8. С.58.
5. Данилов Л.Н. // Педиатрия. 1978. №1. С.76.
6. Игнатъев А.С., Левшов Ю.Н. // Клини. мед. 1971. Т.49. №9. С.149.
7. Капкаев Р.А., Аковбян В.А., Руми Т.К. // Вестн. дерматологии и венерологии. 1984. №2. С.41.
8. Пирожниченко В.В., Демирташова Н.Г. // Клини. хирургия. 1978. №5. С.81.
9. Шамов И.А. // Клини. мед. 1976. Т.54. № 6. С.119.
10. Шутов А.А. // Неврологический раритет. Пермь, 1992. С.109.
11. Шутов А.А., Бажина Л.С. // Клини. мед. 1970. Т.48. № 3. С.134.
12. Эмануэль В.Я. // Клини. мед. 1970. Т.48. № 7. С.115.
13. Эмануэль В.Я., Скорытина И.Л. // Журн. невропатол. и психиатр. 1973. Т.73. Вып. 12. С.1800.
14. Atkinson R.L. Intravenous lidocaine for the treatment of intractable pain of adiposis dolorosa // Int. J. Obes. №6. P.351. 1982.